

ONCO QCM

VAR 1 :

1. * CA 125 augmente fréquemment dans :
 - a. Cancer du pancréas --> CA 19-9
 - b. Cancer des poumons --> ACE
 - c. Cancer des ovaires
 - d. Cancer du sein --> CA 15-3
 - e. Cancer colorectal --> ACE
2. * L'anémie induite par la chimiothérapie est : traitée par EPO
 - a. Normocyte normochrome
 - b. Microcyte hypochrome
 - c. Macrocyte hyperchrome
 - d. Microcyte normochrome
 - e. Macrocyte normochrome
3. * Lequel des médicaments suivants est un inhibiteur de la topoisomérase :
 - a. Cyclophosphamide
 - b. Docetaxel
 - c. Doxorubicin
 - d. Oxaliplatin
 - e. Minotécun

OU

e. Irinotecan --> topo I

- Inhibiteurs de la topo I : Irinotécan, Topotécan
- Inhibiteurs de la topo II : Etoposide, téniposide
4. * Lequel des médicaments suivants N'EST PAS une chimiothérapie :
 - a. Cisplatine --> agent alkylants
 - b. Paclitaxel --> agent antimicrotubulaire
 - c. Exemestane --> inhibiteur aromatasase / enzymes produisant des stéroïdes
 - d. Oxaliplatin --> agent alkylant
 - e. Etoposide --> inhibiteur topoisomérase
5. * Anémie apparaissant pendant la chimiothérapie est basée sur le mécanisme :
 - a. De déficient en fer
 - b. De déficient en B12
 - c. D'inhibition de la moelle osseuse induite par la tumeur
 - d. D'inhibition de la moelle osseuse induite par le traitement --> par chimio
 - e. Auto-immune

TTT = érythropoïétine

6. *Lequel des inhibiteurs de la tyrosine kinase est utilisé dans la leucémie myéloïde chronique :

- a. Sunitinib
 - b. Imatinib
 - c. Sorafenib
 - d. Erlotinib
 - e. Lapatinib
- + Dasatinib
+ Nilotinib

7. *Quelle est l'histologie la plus commune dans le cancer du sein :

- a. Carcinome lobulaire invasif --> 10-15%
- b. Carcinome canalaire invasif = ductal --> 70-80%
- c. Tumeur Phyllodes --> rare
- d. Maladie de Paget
- e. Angiosarcome --> rare

8. *Lequel des facteurs de risques suivants N'EST PAS pour le cancer de l'œsophage :

- a. Alcool
 - b. Syndrome Plummer-Vinson
 - c. Fumer
 - d. Exposition au soleil
 - e. Œsophage de Barrett
- FDR :
- Tabac
- Alcool
- Obésité
- Radiothérapie
- Apport nitrosamine
- Homme > femme
- RGO
- Barrett
- Radiothérapie
- Sd Plummer-Vinson
- Age > 60 ans
- ATCD cancer

9. *Lequel des facteurs de risques suivants N'EST PAS pour le cancer du pancréas :

- a. Fumer
 - b. Alcool
 - c. Obésité
 - d. Syndrome Peutz-Jeghers
 - e. Antécédents personnels de cancer du foie
- FDR :
Génétique :
- BRCA1 et BRCA2
- Syndrome Peutz-Jeghers
- Ataxie, télangiectasie
- FAP et HNPCC
- Environnement :
- Tabac, obésité
- H. P.
- Café, alcool
- AINS
- Gastrectomie

10. *Lequel des facteurs de risques suivants N'EST PAS pour le cancer des poumons :

- a. Fumer
 - b. Régime
 - c. Exposition environnementale au radon
 - d. Exposition aux radiations
 - e. Exposition occasionnelle à l'asbestose
- FDR :
- #1 : tabac
- #2 : amiante
- Exposition radiations : radon, radiothérapie
- Exposition professionnelle
- Maladies pulmonaires
- Génétique

11. *Dans quelle forme de cancer des testicules on peut utiliser une radiothérapie :

- a. Uniquement dans les tumeurs du sac vitellin
- b. Uniquement dans le carcinome embryonnaire
- c. Uniquement dans les seminomes
- d. Uniquement dans les tératomes
- e. Dans tous les types histologiques des cancers testiculaires

TOUTE tumeurs testicules = radiorésistants
sauf séminomes = radiosensibles

12. *CA 19-9 augmente le plus fréquemment dans :

- a. Cancer des poumons
- b. Cancer des ovaires
- c. Cancer du sein
- d. Cancer de la thyroïde
- e. Cancer du pancréas

+ Colon : 20 - 40%
+ Gastrique : 21 - 42%

13. *Lequel est le signe clinique le plus commun du cancer du sein :

- a. Grosseur du sein --> masse tumorale dominante
- b. Mamelon rétracté
- c. Écoulement du mamelon
- d. Mastite carcinomateuse
- e. Peau « d'orange » --> signe avancé

14. *La forme la plus commune de cancer du foie est :

- #2 = 20% a. Cholangiocarcinome
- b. Carcinome à cellules claires
- #1 = 75% c. Carcinome hépatocellulaire
- d. Angiosarcome
- e. Lymphome

Cancers primaires :
- Carcinome hépatocellulaire
- Cholangiosarcome

Cancers secondaires :
- Métastases --> digestives, pulmonaires, sein

15. *Lequel est l'histologie la plus commune dans le cancer rénal :

- a. Carcinome à cellules transitionnelles
- b. Adénocarcinome papillaire = 10-15%
- c. Adénocarcinome à cellules claires = 75-85%
- d. Adénocarcinome chromophobique = 5%
- e. Carcinome embryonnaire

#1 = adénocarcinomes
#2 = carcinomes transitionnels
#3 = tumeur de Wilms

16. Lesquels des virus suivants ont une capacité oncogénique :

- a. Virus Epstein-Barr --> lymphome de Burkitt
- b. Virus Hépatite C --> cancer du foie
- c. Souche 16 du HPV --> cancer col de l'utérus
- d. Virus Influenza
- e. Virus Hépatite B --> cancer du foie

--> HPV : souche 16 et 18

17. La NFS d'un patient sous traitement par chimiothérapie, présente souvent :

- a. Anémie
- b. Polyglobulie
- c. Thrombocytopénie
- d. Neutrophilie
- e. Neutropénie

18. Lesquels des marqueurs suivants sont utilisés dans le cancer colorectal :

- a. AFP --> foie, testicule
- b. CEA
- c. CA 15-3 --> sein
- d. CA 125 --> ovaire
- e. CA 19-9 --> pancréas

19. L'échographie :

- a. A l'avantage de ne pas être invasif
- b. Peut être effectuée même durant une grossesse
- c. Est la méthode de choix dans le diagnostic du cancer des poumons --> testicule, prostate
- d. A une résolution supérieure à une IRM dans le cancer du foie
- e. Peut différencier une tumeur kystique d'une tumeur solide

20. Les investigations endoscopiques ont les avantages suivants :

- a. Permettent des prélèvements de biopsie
- b. Ne sont pas invasives
- c. Sont facilement tolérées par le patient
- d. Permettent la visualisation de l'épithélium des organes creux
- e. Ne requiert jamais de sédation

21. La biopsie à l'aiguille :

- a. Est utilisée dans le cancer du sein > prostate, ovaire
- b. Est effectuée avec des aiguilles spéciales + pancréas
- c. Est utilisée dans le cancer de la prostate + ovaires
- d. Peut être effectuée sous guidage échographique
- e. Ne permettent qu'un diagnostic cytologique limité

22. La stadification TNM :

- a. Il y a 2 types distincts de stadifications : clinique et pathologique
- b. La stadification clinique est basée sur les résultats obtenus par l'examen microscopique de la tumeur
- c. Les stadifications clinique et pathologiques sont toujours identiques
- d. La stadification clinique diffère parfois de la stadification pathologique
- e. La stadification pathologique est basée sur les examens d'imagerie --> histopathologiques

23. Lesquels des cancers suivants sont les plus commun chez les hommes :

- a. Cancer des poumons
 - b. Cancer de la thyroïde
 - c. Cancer gastrique
 - d. Cancer de l'œsophage
 - e. Cancer de la vessie
- + colorectal gauche
+ estomac --> adénocarcinome intestinal
+ foie
+ rein

24. Lesquelles des réponses sont vraies à propos des cancers professionnels :

- a. Ils sont de plus en plus fréquents ces derniers temps
- b. Asbestos peut causer le carcinome du col de l'utérus --> poumons, mésothélium
- c. Les travailleurs de l'industrie des colorants et des peintures développent fréquemment un cancer de la vessie
- d. L'exposition aux composés du benzène peut développer une leucémie
- e. L'exposition aux radiations augmente le risque de leucémie

25. Brachythérapie est :

- a. Une procédure de neurolyse antalgique pour le plexus brachial
- b. Une technique de chimiothérapie intra-artérielle isolée au membre supérieur
- c. Une procédure dans laquelle la tumeur entre en contact avec une source radioactive
- d. Une technique de radiothérapie
- e. Une méthode d'implantation d'un dispositif de perfusion de chimiothérapie

26. La chimiothérapie effectuée avant la chirurgie curative, est appelée :

- a. Chimiothérapie primaire
- b. Chimiothérapie adjuvante --> post-opératoire
- c. Chimiothérapie néoadjuvante
- d. Chimiothérapie palliative --> pas curative
- e. Chimiothérapie accélérée

27. Laquelle de ces réponses sont vraies à propos du cancer gastrique :

- a. Approximativement 95% des cancers gastriques sont des adénocarcinomes
- b. L'adénocarcinome diffus est localisé dans l'estomac distal --> transmural, lymphatique
- c. L'adénocarcinome intestinal est localisé dans l'estomac distal
- d. L'adénocarcinome diffus à un meilleur pronostic --> pronostic réservé
- e. L'adénocarcinome intestinal à un meilleur pronostic

28. Laquelle de ces réponses sont vraies à propos du cancer colorectal :

- a. Est rarement curable, même dans les stades précoces --> FAUX
- b. L'incidence diminue avec l'âge --> augmente
- c. L'activité physique et l'obésité n'influencent pas le risque de développer un cancer colorectal --> FAUX
- d. Les fumeurs ont un risque plus élevé --> 30-40%
- e. La polypose adénomateuse familiale (FAP) est un facteur de risque --> 1%

29. Laquelle de ces réponses sont vraies à propos du cancer du foie :

- a. Les tumeurs malignes du foie peuvent être à la fois des tumeurs primaires et des tumeurs secondaires --> hépatocellulaire/cholangiocarcinome ou bien métastases colorectale, pulmonaire ou du sein
- 6ie --> b. Le cancer du foie est l'un des plus rares cancers au monde
- c. Apparaît exclusivement chez les femmes H / F = 2,5 : 1
- d. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus commune
- e. Le taux de survie à 5 ans est proche des 50%

30. Les symptômes fréquents dans le cancer de l'œsophage sont :

- a. Régurgitation
- b. Dysphagie + nausées
- c. Vomissements + odynophagie
- d. Perte de poids + symptômes de dissémination
- e. Hématurie

31. L'examen clinique des patients avec un carcinome hépatocellulaire, montre :

- a. Hépatomégalie + asthénie
- b. Splénomégalie + perte poids et appétit
- c. Circulation abdominale collatérale + nausées et vomissement
- d. Ascite + fièvre
- e. Tumeur palpable au touché rectal + jaunisse
- + douleur hypochondre droit +/- irradier

32. Lesquelles des histologies suivantes sont caractéristiques pour le cancer des testicules :

- a. Carcinome à cellules en « bague à chaton » --> estomac, vessie, prostate
- b. Tumeur du sac vitellin
- c. Choriocarcinome = non séminomateuses
- d. Carcinome embryonnaire
- e. Carcinome à cellules transitionnelles --> prostate, rein, vessie

33. L'adénocarcinome rénal est :

- a. Sensible à la chimiothérapie
- b. Résistant à la chimiothérapie
- c. Sensible à la radiothérapie
- d. Résistant à la radiothérapie
- e. Sensible aux thérapies anti-angiogéniques --> Sunitinib, Pazopanib, Axitinib, Sorafenib, Lenvatinib, Cabozantinib

34. Les antigènes carcino-embryonnaire est fréquemment élevé dans :

- a. Le cancer colorectal
- b. Le cancer des poumons + hépatocellulaire
- c. Le cancer du sein + testicule non séminomateux
- d. Les cancers tête et cou + hépatite
- e. La méningite bactérienne + cirrhose

35. Les réponses sont vraies à propos de l'IRM :

- a. Est basé sur l'utilisation de rayons X --> scanner
- b. Est basée sur l'utilisation d'un champ magnétique
- c. Est contre-indiquée en présence de divers dispositifs métalliques ou pacemakers
- d. Est plus efficace que la tomographie dans l'évaluation des lésions au cerveau ou au bassin
- e. La durée d'une IRM est très courte, quelques secondes

36. Plusieurs critères microscopiques suggèrent la malignité :

- a. Variation des cellules en taille et forme
- b. Activité mitotique faible --> élevée
- c. Des noyaux de différentes formes
- d. Un arrangement organisé des cellules --> désorganisé
- e. Activité mitotique augmentée

37. Les systèmes de classement des tumeurs malignes :

- a. Apprécient le degré de différenciation des tissus
- b. Considèrent le nombre de mitoses
- c. Déterminent la taille de la tumeur primaire
- d. Considèrent le pléomorphisme nucléaire
- e. Considèrent l'existence des métastases à distance

38. Le suivi de patients cancéreux :

- a. Détectent une rechute précoce
- b. Est appelé screening (dépistage) --> prévention secondaire
- c. Est appelé prévention primaire --> éviter d'être exposé au cancérigènes
- d. Est appelé prévention secondaire --> screening
- e. Est appelé prévention tertiaire

39. Lesquelles des réponses suivantes sont vraies à propos de la brachythérapie :

- a. Les sources irradiantes sont placées en contact rapproché avec le tissu tumoral
- b. La brachythérapie de surface est utilisée dans le cancer de la prostate --> interstitielle
- c. Des implants intra-cavitaires sont utilisés dans le cancer du col de l'utérus
- d. Les techniques de postcharge protègent le personnel médical
- e. La brachythérapie interstitielle est utilisée pour le cancer de la peau --> de surface

40. Lesquelles des antiémétiques suivants sont des antagonistes de la sérotonine :

- a. Ondansetron
- b. Aprepitant
- c. Metoclopramide
- d. Palonosetron
- e. Prochlorperazine

41. Lesquelles des facteurs de risque suivants sont pour.... : le cancer du sein :

- a. Cycle menstruel... et ménopause précoce *tardif --> inverse
- b. Contraceptifs oraux
- c. Obésité
- d. Alcool
- e. Venant d'un pays pauvre

42. Trastuzumab :

- a. Est un Ac monoclonal anti-HER2
- b. Est un Ac monoclonal anti-CD20
- c. Est un Ac monoclonal anti-VEGF
- d. Peut être associé avec de la chimiothérapie
- e. Est utilisé dans certains types de cancer du sein

43. Lesquelles des réponses sont vraies concernant le pronostic du cancer de l'œsophage :

- a. Il a un bon pronostic, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 40%
- b. La stadification TNM est le facteur pronostic le plus important
- c. Une perte de poids supérieure à 10% du poids corporel est accompagné d'un mauvais pronostic
- d. Les métastases hépatiques n'influencent pas le pronostic
- e. Les tumeurs dans le bas et moyen ... ont un mauvais pronostic

44. Lesquelles des suivants sont des syndromes paranéoplasiques dermatologiques :

- a. Ichtyose acquise
- b. Syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH
- c. Syndrome Eaton-Lambert
- d. Acanthosis Nigricans
- e. Myasthénie gravis

45. Nausées et vomissement causés par la chimiothérapie peuvent être :

- a. Aigues durant les 24 premières heures du traitement
- b. Retardés, commençant 24h après le traitement
- c. D'intensité constante durant la durée de la chimiothérapie
- d. Par anticipation, avant administration
- e. La chimiothérapie n'induit jamais ni nausées ni vomissements

46. Dans le cancer du sein, le traitement peut être :

- a. Chirurgical
- b. Par irradiations
- c. Chimique, utilisant des inhibiteurs de l'aromatase (IA)
- d. Chimique, utilisant des analogues GnRH
- e. Chimique, utilisant des anti-oestrogènes

47. Les facteurs de risques dans le cancer du foie sont :

- a. Infection HBV
- b. Infection HCV
- c. Cirrhose
- d. Ingestion d'aliment contaminés à l'aflatoxine
- e. Exposition au soleil

48. Des saignements dans le cancer colorectal, peuvent être :

- a. Un des premiers signes cliniques du cancer colorectal
- b. Sous forme de méléna
- c. Sous forme de sang frais dans les selles
- d. Sous forme d'une hémorragie occulte
- e. Sous forme d'hématémèse

49. Les réponses suivantes concernant le traitement du cancer colorectal sont vraies :

- a. La chimiothérapie est utile uniquement chez les patients avec des maladies métastatiques
- b. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer rectal
- c. La combinaison de chimiothérapie et d'Ac monoclonaux, prolongent la survie du patient avec un cancer colorectal métastasé
- d. On utilise souvent une combinaison de chimiothérapie basée sur 5-FU ou Capécitabine
- e. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du colon proximal

50. Lesquelles de ces médicaments sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase utilisés dans le cancer rénal :

- a. Sunitinib
- b. Tensirolimus
- c. Bevacizumab
- d. Everolimus
- e. Sorafenib

Var 2 :

1. *Parmi les étiologies suivantes, laquelle est la plus fréquente dans le cancer du rein ?
 - a. Carcinome transitionnel
 - b. Adénocarcinome papillaire
 - c. Adénocarcinome à cellules claires
 - d. Adénocarcinome chromophile
 - e. Carcinome embryonnaire
2. *Les métastases néoplasiques de la prostate les plus fréquentes sont :
 - a. Hépatiques
 - b. Cérébrales
 - c. Osseuses
 - d. Pulmonaires
 - e. Cutanées
3. *Lequel des éléments suivants n'est pas un élément pronostic négatif pour un patient atteint d'un adénocarcinome bronchopulmonaire :
 - a. Perte de poids involontaire de 10kg au cours des 6 derniers mois
 - b. Mutation de l'EGFR présente
 - c. Indice de performance ECOG 3
 - d. Nodule pulmonaire controlatéral
 - e. Métastases hépatiques
4. *Quelle est la fréquence des cancers du sein hormonodépendants :
 - a. Moins de 5 %
 - b. 20 à 30 %
 - c. 40 à 50 %
 - d. 60 à 70 %
 - e. Plus de 90%
5. *Quel est le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus ?
 - a. Une exposition prolongée aux œstrogènes
 - b. Une exposition prolongée aux rayons du soleil
 - c. Un contact sexuel non protégé
 - d. Une infection par HP
 - e. Une alimentation riche en protéines et en graisses animales

???

6. *Le type de cancer du foie le plus fréquent est :
- a. L'hépatocarcinome
 - b. Le cholangiocarcinome
 - c. L'hépatoblastome
 - d. Angiosarcome
 - e. Lymphome
7. *Les syndromes paranéoplasiques qui peuvent être observés dans le cancer gastrique sont :
- a. L'acanthosis nigricans
 - b. La dermatomyosite
 - c. Le syndrome de Trousseau
 - d. Le syndrome néphrotique
 - e. Toutes les réponses ci-dessus
8. *Laquelle des affirmations suivantes concernant la résistance biochimique à la chimiothérapie est fausse :
- a. La tumeur peut être incapable de convertir l'agent antinéoplasique en sa forme active
 - b. La résistance pléiotrope est donnée par un type de structure cellulaire de pompe à membrane
 - c. La cellule peut augmenter le niveau d'enzymes cibles que l'agent cytotoxique à l'intention d'inactiver
 - d. La résistance est due à un déficit d'irrigation du tissu malin
 - e. La cellule peut augmenter l'expression des enzymes de réparation de l'ADN
9. *Quel est le signe clinique le plus fréquent au début du cancer du sein :
- a. Nodule mammaire tumoral
 - b. Adénopathies axillaires
 - c. Fuite du mamelon
 - d. Mastite carcinomateuse
 - e. Peau d'orange
10. *Lequel des médicaments suivants sont des antibiotiques antitumoraux :
- a. Analogue de l'azote de la moutarde
 - b. Nitrosurées
 - c. Analogue de la purine
 - d. Anthracyclines
 - e. Taxanes

11. *Lequel des médicaments antiémétiques suivants est un antagoniste de la neurokinine 1 (NK-1) ?

- a. Ondansétron
- b. **Aprépitant**
- c. Métoclopramide
- d. Palonosétron
- e. Prochlorpérazine

12. *Lequel des médicaments suivants est un cytostatique :

- a. Tamoxifène
- b. **Paclitaxel**
- c. Tramstuzumab
- d. Imatinib
- e. Exémestan

Cytostatiques :
- Carboplatine
- Gemcitabine
- Paclitaxel
- Bevacizumab

- Pemetrexed
- Vinorelbine
- Docetaxel

13. *Le bortézomib est :

- a. Inhibiteur de la kinase mTOR
- b. Anticorps monoclonal
- c. Inhibiteur de la tyrosine kinase
- d. Une cytokine
- e. **Un inhibiteur du protéosome**

14. *Les niveaux de CA 19-9 augmentent le plus souvent dans :

- a. Le cancer du poumon
- b. Le cancer de l'ovaire
- c. Le cancer du sein
- d. Le cancer de la thyroïde
- e. **Le cancer du pancréas**

15. *Inhibiteurs de l'aromatase :

- a. **Réduit le niveau d'œstrogène par le blocage de la synthèse**
- b. Réduit le niveau d'œstrogène par la liaison des récepteurs d'œstrogène
- c. Réduit le niveau d'œstrogène par la liaison des récepteurs d'œstrogène-progestérone
- d. Réduit le niveau d'œstrogène par la castration chimique
- e. Réduit le niveau d'œstrogène par la castration chimique et la liaison des œstrogènes récepteurs

ACE

16. Les antigènes carcinoembryonnaires ont des valeurs fréquentes... élevées chez les individus :

- a. Atteints d'un cancer colorectal
- b. Atteints d'un cancer du poumon
- c. Atteints d'une cirrhose hépatique
- d. Non-fumeurs
- e. Atteints de méningite bactérienne

17. Les affirmations suivantes sont vraies à propos de l'IRM :

- a. Sont basées sur l'utilisation des rayons X
- b. Sont basées sur la propriété des atomes d'hydrogène dans un champ magnétique
- c. Est contre-indiquée en présence de dépôts métalliques et de stimulateurs cardiaques
- d. Est plus efficace que la TDM pour évaluer les lésions cérébrales ou pelviennes
- e. La durée d'une IRM est très courte

18. Une série de critères suggérant microscopiquement une malignité :

- a. Pléomorphisme cellulaire
- b. Activité mitotique diminuée
- c. Pléomorphisme nucléaire
- d. Conservation de l'architecture tissulaire
- e. Hyperchromie nucléaire

19. Immunohistochimie :

- a. Est utilisée uniquement pour les tumeurs testiculaires
- b. Permet la détection de certains antigènes exprimés au niveau cytoplasmique ou nucléaire au niveau de la membrane
- c. Permet le phénotypage de la tumeur et sa classification dans un certain type tumoral
- d. Est un examen complémentaire utile dans l'anaplasie tumorale avec un point de sortie non précis
- e. Nécessite un examen scintigraphique initial

20. Classification des tumeurs malignes :

- a. Apprécie l'anaplasie cellulaire
- b. Apprécie le nombre de mitoses
- c. Apprécie la taille de la tumeur primaire
- d. Apprécie le pléomorphisme nucléaire
- e. Apprécie l'existence de métastases à distance

21. Voici des exemples d'études épidémiologiques analytiques :

- a. Études d'incidence
- b. Études descriptives
- c. Études de cohorte
- d. Études cas-témoins
- e. Études de mortalité

22. Lesquelles des affirmations suivantes concernant les facteurs de risque alimentaires sont vraies :

- a. La consommation de légumes et de fruits augmente le risque de cancers digestifs
- b. Le glucane végétal peut augmenter l'immunité de la paroi intestinale
- c. Les phytoestrogènes ont un effet protecteur contre le cancer du sein et de la prostate
- d. L'huile d'olive est un facteur de risque oncologique
- e. Les aflatoxines fongiques sont le principal facteur de risque de cancer du poumon

23. Suivi post-thérapeutique :

- a. Est également appelé dépistage
- b. Est également appelé suivi
- c. Est également appelé prévention primaire
- d. Est également appelé prévention secondaire
- e. Est également appelé prévention tertiaire

24. Le rôle de la chirurgie dans le diagnostic et la stadification des tumeurs malignes :

- a. Est de plus en plus important à mesure que de nouvelles techniques de stadification se développent
- b. Est réalisée comme procédure initiale dans tous les néoplasmes digestifs
- c. Permet la biopsie chirurgicale
- d. Permet de réaliser l'excision tumorale ultérieure sous la même anesthésie session
- e. Est la procédure qui définit le stade du TNM dans la LAM

A???

25. La chirurgie reconstructive chez le patient oncologique :

- a. Améliore la survie
- b. Répare les défauts
- c. Améliore la qualité de vie
- d. Restaure la fonctionnalité des organes ou segments affectés
- e. Réduit la masse tumorale

26. Lesquelles des affirmations suivantes concernant la curiethérapie/brachythérapie sont vraies :

- a. En curiethérapie, les sources de rayonnement sont en contact intime avec le tissu tumoral
- b. La curiethérapie endocavitaire est particulièrement utilisée dans le cancer de la prostate
- c. La curiethérapie de contact est utilisée dans le cancer du col de l'utérus
- d. Les techniques de postchargement protègent le personnel médical de l'irradiation
- e. La curiethérapie interstitielle est utilisée dans le cancer de la cavité buccale.

27. Les avantages de la chimiothérapie néoadjuvante sont les suivants :

- a. Réduire la probabilité de récurrence systémique ultérieure
- b. Etre effectuée après l'ablation de la tumeur primaire et permettre l'obtention d'images microscopiques informatives sur la tumeur --> pré-opératoire
- c. Permet d'évaluer l'efficacité du traitement en mesurant la taille de la tumeur primaire
- d. Réduit la masse de la tumeur primaire et facilite la progression chirurgicale
- e. Est réalisée à de faibles doses qui n'entraînent pas de complications immédiates ou tardives

28. Les combinaisons de chimiothérapie reposent sur les principes suivants :

- a. Substances qui génèrent des mécanismes de résistance différents
- b. Substances qui agissent par le même mécanisme
- c. Substances ayant des effets indésirables différents
- d. Substances qui agissent à différents moments du cycle cellulaire
- e. Substances qui agissent par des mécanismes différents

29. Thrombocytopénie pendant la chimiothérapie :

- a. Est rarement grave ou met rarement la vie en danger
- b. Déterminer le traitement si les plaquettes sont $< 100\,000 / \text{mm}^3$
- c. Déterminer le traitement si les plaquettes sont $< 10\,000 / \text{mm}^3$
- d. Déterminer le traitement si les plaquettes sont $< 50\,000 / \text{mm}^3$
- e. Peut être corrigée par des plaquettes

30. Lesquels des éléments suivants constituent des facteurs de risque de cancer du sein :

- a. Cycle menstruel avec apparition tardive et ménopause précoce --> inverse
- b. Contraceptifs oraux
- c. Obésité
- d. Alcool
- e. Venir d'un pays pauvre

31. Le transtuzumab :

- a. Est un anticorps monoclonal anti-HER2
- b. Est un anticorps monoclonal anti-CD20 --> Rituximab
- c. Est un anticorps monoclonal anti-VEGF --> Bevacizumab
- d. Peut être associé à une chimiothérapie
- e. Est indiqué dans le cancer colorectal métastatique --> cancer du sein

32. Lesquelles des affirmations suivantes concernant le pronostic du cancer de l'œsophage sont vraies :

- a. Le cancer de l'œsophage a un bon pronostic, la survie à 5 ans étant > 40 % --> inférieur 40%
- b. Le statut TNM est le facteur pronostique le plus important
- c. Une diminution de > 10 % du poids corporel est associée à un pronostic plus sombre
- d. La présence de métastases hépatiques n'influence pas le pronostic --> FAUX
- e. La localisation de la tumeur au niveau du tiers inférieur et moyen a un pronostic plus sombre

33. Les facteurs pronostiques du cancer colorectal sont :

- a. Le grade tumoral, tumeurs G1 et G2 avec un pronostic plus sombre que G3 et G4 --> G1-G2 > G3-G4
- b. Le type histopathologique, carcinome à cellules en bague à chaton et carcinome mucineux ayant un pronostic plus réservé
- c. Le stade TNM est l'élément pronostique le plus important
- d. Invasion lymphatique ou veineuse
- e. Tumeur résiduelle

34. Les facteurs de risque du cancer du pancréas sont :

- a. Le tabagisme
- b. Un régime alimentaire hyperlipidique
- c. Une gastrectomie partielle
- d. Une pancréatite chronique
- e. Une exposition excessive au soleil --> FAUX

35. Les symptômes observés dans le cancer gastrique sont les suivants :

- a. Douleur épigastrique
- b. Anorexie
- c. Satiété précoce
- d. Vomissements alimentaires
- e. Hématurie

36. Les facteurs pronostiques négatifs du cancer du pancréas sont :

- a. L'âge avancé
- b. La localisation à la tête du pancréas
- c. Le stade avancé de la maladie
- d. Une tumeur peu différenciée
- e. Une tumeur bien différenciée

B??

37. Lequel des éléments suivants constitue un facteur de risque de cancer du poumon ?

- a. Cirrhose du foie
- b. Exposition à l'amiante
- c. Exposition au radon
- d. HTA
- e. Diabète sucré

38. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies concernant la radiothérapie dans le cancer du poumon ?

- a. La TDM prophylactique crânienne est réalisée uniquement chez les patients atteints d'un cancer non à petites cellules --> PETITES CELLULES
- b. La radiothérapie radicale irradie la tumeur primaire, les ganglions hilaires et le médiastin
- c. La RT palliative peut être utilisée dans le syndrome de la veine cave supérieure
- d. La chimio-radiothérapie concomitante apporte un bénéfice à la thérapie séquentielle
- e. La RT radicale est réalisée jusqu'à un maximum de 12 Gy --> 60 Gy

39. Chimiothérapie dans le cancer de la prostate :

- a. Est généralement une solution utilisée tardivement après l'hormonothérapie
- b. Est le traitement initial du cancer de la prostate métastatique --> tardif
- c. Le docétaxel et la prednisone sont utilisés en première ligne de chimiothérapie --> Docétaxel
- d. La mitoxantrone peut être utilisée chez les patients qui ne tolèrent pas le traitement par taxane
- e. Utilise des combinaisons de 3 à 4 cytostatiques qui donnent des réponses plus efficaces --> FAUX

40. Laquelle des histologies suivantes est caractéristique d'un cancer des testicules

- a. Carcinome cellulaire à cellules en bague à chaton
- b. Tumeur du sac vitellin
- c. Coriocarcinome
- d. Carcinome transitionnel --> vessie
- e. Carcinome embryonnaire

41. Lequel des médicaments suivants sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase utilisés dans le néoplasme rénal ?

- a. Sunitinib
- b. Temsirolimus --> inhibiteur mTOR
- c. Bevacizumab --> anti-VEGF
- d. Évérolimus --> inhibiteur mTOR
- e. Sorafénib

42. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies à propos de l'adénocarcinome endométrial ?

- a. Survient dans 20 % des cas de cancer de l'endomètre --> 80-90%
- b. A un meilleur pronostic que l'adénocarcinome à cellules claires
- c. Les cellules ont des niveaux accrus de récepteurs de progestérone
- d. Affecte plus souvent les personnes âgées --> jeunes femmes
- e. Est associé à l'obésité et au diabète

43. Laquelle des affirmations suivantes concernant le traitement systémique du cancer de l'endomètre est vraie :

- a. La chimiothérapie systémique est indiquée dans les formes avancées ou récurrentes
- b. L'hormonothérapie est particulièrement indiquée dans les tumeurs bien différenciées avec des récepteurs hormonaux positifs
- c. L'hormonothérapie est indiquée dans le traitement adjuvant du cancer de l'endomètre --> FAUX
- d. L'hormonothérapie est indiquée dans les formes métastatiques ou récurrentes
- e. L'hormonothérapie utilise du bicalutamide ou des analogues de la GnRH --> progestatifs

44. Lesquelles des affirmations suivantes concernant le cancer de l'ovaire sont vraies :

- a. La plupart des cancers de l'ovaire sont des tumeurs germinales
- b. La plupart des cancers de l'ovaire sont des tumeurs stromales --> FAUX
- c. La plupart des cancers de l'ovaire sont d'origine épithéliale
- d. Sont généralement des tumeurs chimiosensibles
- e. Sont généralement détectés à des stades avancés

45. Lesquelles des affirmations suivantes concernant le cancer de l'ovaire sont vraies :

- a. La dissémination la plus fréquente est l'ensemencement péritonéal
- b. La dissémination la plus fréquente est hématogène --> secondaire
- c. Les métastases pulmonaires et cérébrales sont rares
- d. Le cancer de l'ovaire est le plus souvent détecté à un stade précoce, limité à l'ovaire --> stade tardif
- e. L'os est le lieu le plus fréquent de métastase --> rare

46. Quelles interventions chirurgicales peuvent être utilisées dans le cancer du col de l'utérus :

- a. Conisation
- b. Tumorectomie
- c. Hystérectomie radicale avec lymphadénectomie pelvienne bilatérale
- d. Sectorectomie --> sein
- e. Exentération pelvienne

47. Gènes de suppression tumorale :

- a. Peuvent donner naissance à des proto-oncogènes par mutations --> FAUX
- b. Contrôlent le cycle cellulaire
- c. Sont également appelés proto-oncogènes --> FAUX
- d. Jouent un rôle dans la carcinogenèse
- e. Le plus connu est le p53, qui joue le rôle de gardien génomique

48. L'anémie dans le cancer peut être due :

- a. Le plus souvent à un mécanisme auto-immun --> rare
- b. A une inhibition directe de l'érythropoïèse par la tumeur par la production de cytokines
- c. A un mécanisme de carence en fer par le biais d'hémorragies occultes
- d. A un œdème
- e. A une infiltration directe de MOH

49. Dans les métastases hépatiques, des modifications peuvent survenir dans :

- a. Les transaminases
- b. La bilirubine
- c. Le PSA --> prostate
- d. L'albumine sérique
- e. Les tests de coagulation

50. Les affirmations suivantes concernant le traitement du cancer colorectal sont vraies :

- a. La chimiothérapie n'est utile que chez les patients atteints de tumeurs non résecables ou métastatiques maladie --> aussi adjuvant
- b. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du rectum
- c. L'association d'anticorps monoclonaux à la chimiothérapie permet de prolonger la survie des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique
- d. La chimiothérapie utilise généralement des combinaisons à base de 5-FU ou de capécitabine
- e. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer et du cancer du côlon proximal --> FAUX